

대장내시경 장정결, 1L 저용량으로 4L만큼 깨끗하게

1L 저용량 장정결제는 4L와 같거나 더 깨끗하게 비우고, '다시 받겠다'는 분이 더 많았습니다
— 2026년 연구 근거

대장내시경에서 가장 힘든 것은 '장 비우기'입니다

마시는 양의 부담이 검진을 미루게 하는 가장 큰 이유입니다 — 1L 저용량이 이 부담을 줄입니다

1L

저용량 장정결제

PEG-아스코르브산 1L + 물

665명

연구에 참여한 환자

입원 성인 · 이탈리아 7개 병원 무작위 비교

연구 결과(입원 성인 대상)

1L는 2L·4L와 **같거나 더 깨끗하게** 비웠고, 특히 오른쪽 대장이 더 깨끗했습니다.
'다시 받겠다'는 분도 더 많았습니다. 다만 **구토·갈증은 1L에서 더 잦았습니다**.

누구에게 의미가 있나

마시는 양이 부담스러운 분, 특히 **고령인 분**의 부담을 줄여 줍니다. 콩팥·심장 질환이 있으면 어떤 약을 쓸지 담당 의사가 정합니다.

Tip · 장을 잘 비워야 작은 용종까지 놓치지 않습니다.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 665명 무작위 비교

검사의 정확도는 '얼마나 깨끗이 비웠는가'에 달려 있습니다

목표 — 장 청결 점수(보스턴 척도) 6점 이상, 오른쪽 대장을 포함한 모든 구역 2점 이상

1 용종 발견 정확도

덜 비우면 5mm 미만 작은 용종이나 초기 암을 놓칠 수 있습니다.

2 검사 시간 편안함

찌꺼기를 씻어 내느라 검사와 진정(수면) 시간이 길어집니다.

3 다시 검사 비용

잘 안 비워지면 1년 안에 다시 검사하도록 권합니다.

4 다음 검진 꾸준함

4L는 절반이 다 못 마십니다 — 힘들면 다음 검진을 피하게 됩니다.

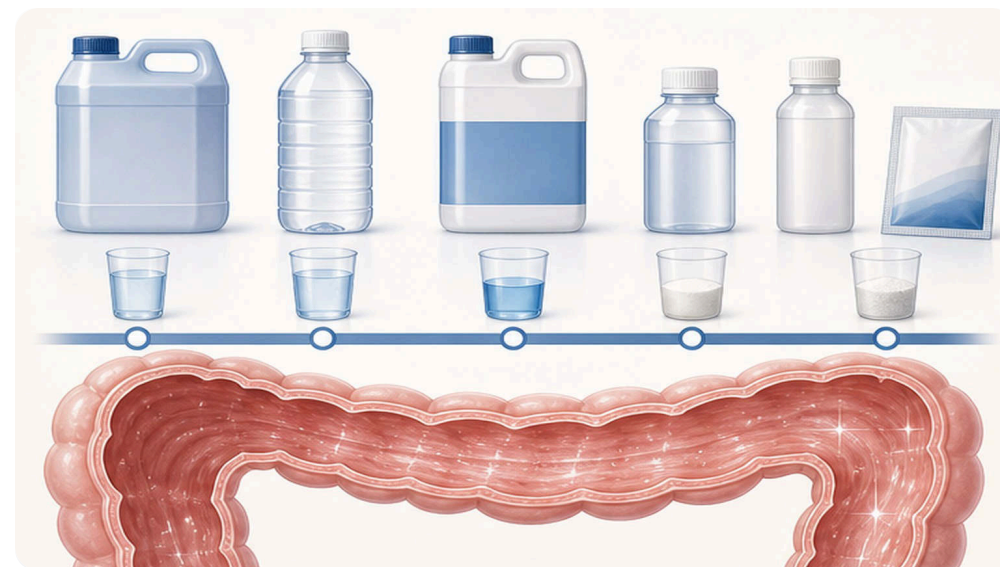


그림 · 큰 통에서 작은 병까지 — 마시는 양은 달라도 목표는 깨끗한 대장입니다 (설명용 그림).

Tip · 광교바른내과는 검진 대장내시경에서 1L 저용량을 먼저 권하고, 상태에 따라 2L·4L도 준비합니다.

근거 · 미국 대장암 합동위원회(USMSTF) 2025 · ESGE 2019 장정결 지침

1L · 2L · 4L, 무엇이 다른가요

세 가지 모두 전날과 당일로 나눠 마십니다 — 입원 성인 665명 무작위 비교 연구 결과

항목	1L 저용량	2L	4L
마시는 양	약 1L + 물 0.5L	약 2L + 물 1L	4L
오른쪽 대장이 아주 깨끗한 비율	가장 높음	중간	낮음
전체적으로 충분히 깨끗한 비율	같음	같음	같음
‘다시 받겠다’는 환자	가장 많음	중간	가장 적음
구토 · 갈증	더 잦았음	1L보다 적음	1L보다 적음

Tip · 1L와 2L는 PEG-아스코르브산, 4L는 일반 PEG 장정결제입니다.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 665명 1:1:1 무작위 비교

1L 저용량이 특히 도움이 될 수 있는 분

해당하면 진료 때 1L를 상의해 보세요 — 콩팥·심장 질환이 있으면 담당 의사가 약을 정합니다

65세 이상

4L를 다 마시기 어렵고 탈수·전해질 변화 위험이 커서, 적은 양이 부담을 덜어 줍니다.

콩팥 기능이 떨어진 분

콩팥 기능 수치(사구체여과율) 30~60. 인산염
장정결제는 쓰지 않습니다 — 약 종류는 담당
의사가 정합니다.

심부전이 있는 분

물을 한꺼번에 많이 마시면 폐에 물이
찰 수 있습니다. 약 종류와 양은 심장 상태를 보고
담당 의사가 정합니다.

지난번 장 비우기에 실패한 분

4L를 다 못 마셔 다시 검사하라는 말을 들었다면,
1L가 끝까지 마시는 데 도움이 됩니다.

정기적으로 검진받는 분

5년·10년마다 받는 분은 '다음에도 받겠다'는
마음을 이어 가는 것이 중요합니다.

주의 · 구토에 예민한 분

연구에서 1L는 **구토·갈증이 더 잦았습니다**. 구토에
예민하면 담당 의사와 제제를 함께 고르세요.

Tip · 콩팥·심장 질환, 복용 중인 약은 예약할 때 꼭 알려 주세요.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · USMSTF 2025 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

안전하게 쓸 수 있었지만, 1L는 구토·갈증이 더 잦았습니다

입원한 성인 대상 연구 — 다 마시기는 쉬웠고 청결도도 좋았지만 불편의 종류가 달랐습니다

1 전해질 나트륨·칼륨·염소

세 군 모두 치료가 필요한 변화는 없었습니다.

2 콩팥 기능 크레아티닌·사구체여과율

의미 있는 변화가 없었습니다.

3 구토·갈증 1L에서 더 잦음

1L군에서 더 자주 생겼습니다 — 구토에 예민하면 담당 의사와 상의하세요.

4 심각한 부작용 0%

세 군 모두 한 건도 보고되지 않았습니다.

연구 대상

입원한 성인이 대장내시경을 받을 때 비교한 연구입니다. 다 마신 비율과 '다시 받겠다'는 의향은 1L가 가장 높았습니다.



그림 · 수분·콩팥·전해질 균형을 확인하며 안전하게 준비합니다.

Tip · 복용 중 이상하면 참지 말고 바로 연락하세요(9쪽 위험 신호).

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 다기관 무작위 비교

1L 저용량, 전날 저녁과 당일 새벽에 나눠 마십니다

한 번에 다 마시지 않고 둘로 나누는 것(분할 복용)이 가장 깨끗합니다



그림 · 밤에 한 번, 아침에 한 번 — 둘로 나눠 마시면 대장이 더 깨끗해집니다 (설명용 그림).

Tip · 한 번에 다 마시지 말고 1~2시간에 걸쳐 천천히 마시세요.

1 전날 아침·점심 부드러운 식사

흰죽·미음·두부 등. 저녁부터는 맑은 음료만 마십니다.

2 전날 저녁 1차 0.5L

약 0.5L를 1~2시간 동안 천천히, 이어서 물 0.25L. 시각은 받은 복용 시간표대로.

3 검사 당일 새벽 2차 0.5L

0.5L + 물 0.25L. 검사 4~5시간 전까지 다 마십니다.

4 병원 도착 전 마지막 확인

변이 열린 노란 물이면 잘 된 것. 갈색·찌꺼기가 있으면 알려 주세요.

근거 · ESGE 2019 분할 복용 원칙 · 광교바른내과 표준 안내

검사 전 약은 이렇게 조절합니다

스스로 끊지 말고, 담당 의사와 미리 확인하세요 — 날짜별 일정은 준비 안내문을 따릅니다

철분제 · 지사제

검사 **7일 전**부터 중단 — 변을 검게 만들어 청결도를 보기 어렵게 합니다.

피를 묽게 하는 약

스스로 끊지 않습니다. 용종 절제 가능성이 있으면 끊을지, 며칠 전 끊을지는 약마다 달라 **의료진이 정합니다.**

당뇨약 · 인슐린

예약 때 받은 개별 지시대로 줄이거나 거릅니다. ‘-글리플로진’(SGLT2 억제제)은 **3일 전**부터 쉬는 경우가 많아 예약 때 알립니다.

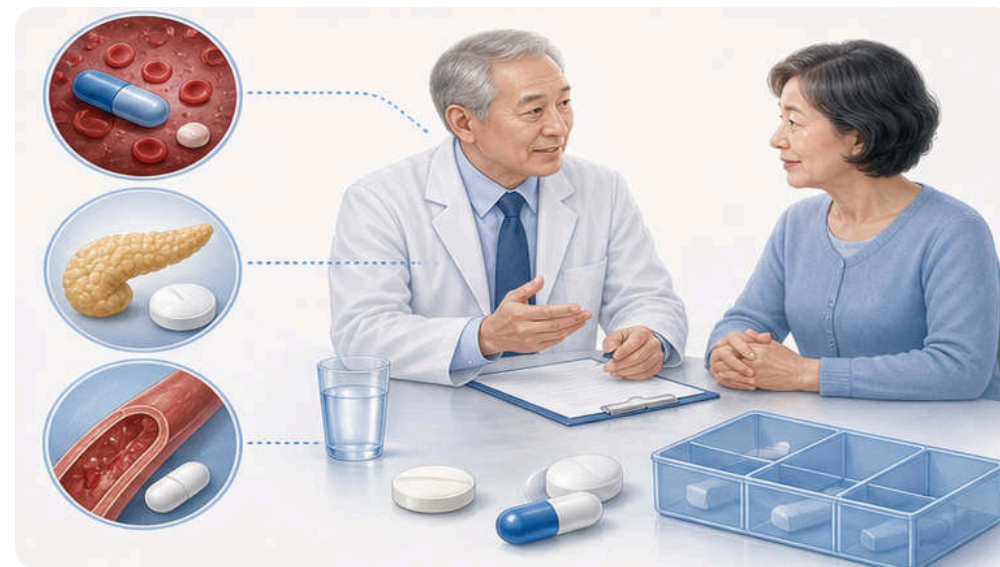


그림 · 먹는 약을 모두 가져와 의사와 함께 조절합니다(설명용 그림).

Tip · 혈압약·심장약은 당일에도 적은 물로 평소대로 드세요 — 이뇨제만 당일 한 번 거릅니다.

근거 · BSG/ESGE 항혈전제 지침 2021 · ACG-CAG 2022 · ADA 2026 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

이런 증상이 생기면 바로 병원에 연락하세요

장정결제를 마시는 동안이나 검사 전후에 생기면 참지 마세요

증상	이런 경우	무엇을 해야 하나
반복 구토	마신 뒤 3번 넘게 토해 거의 못 마심	1L도 못 채우면 검사 연기를 검토합니다
심한 복통 · 배가 똥똥함	참기 힘든 통증, 가스도 안 나옴	장이 막혔을 수 있어 바로 확인이 필요합니다
피 섞인 변 · 검은 변	붉은 음식을 안 먹었는데 피 섞인 변·검은 변	출혈 확인이 필요합니다
어지러움 · 쓰러질 것 같음	탈수·혈압 저하 신호	앉아서 다리를 올리고 물·이온음료를 마시며 연락
가슴 두근거림	전해질 변화 가능 — 심장약 드시는 분은 특히	바로 진료를 받습니다
38°C 이상 열 · 오한	다른 감염이나 드물게 장이 뚫린 신호	검사를 미루고 바로 연락합니다

Tip · 증상이 생기면 바로 031-893-4560 으로 연락하세요.

근거 · 광교바른내과 환자 안전 표준

부담은 줄이고, 정확도는 그대로

QR로 다시 보기 · 식사 일정·복용 시각·약 조절은 [대장내시경 준비 안내문](#)을 따르세요

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

대장내시경을 앞둔 분과 가족을 위한 준비 안내자료입니다. 장정결제 종류와 약 조절은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · USMSTF 2025 · ESGE 2019 장정결 지침 · ACG-CAG
2022·ASGE 2016 항혈전제 지침 · ADA 2026 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요